

## **Asignatura: Salud del niño, niña y adolescente Guía para el estudiante**

### **MÓDULO NEONATAL: Parte 2**

***“Para cambiar al mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer”  
(Michel Odent)***



#### **Módulo Neonatal:**

##### **Contenidos:**

Preparación para el parto. Nacimiento y recepción de la persona recién nacida sana. Primera hora de vida. Apgar. Examen físico de la persona recién nacida. Profilaxis de patologías neonatales. Pesquisas recomendadas: Enfermedades metabólicas congénitas. Cardiopatías congénitas. Hipoacusia. Reflejo rojo. Displasia luxante de cadera. Lactancia. Puericultura. Recomendaciones al alta.

##### **Objetivo general:**

- Adquirir habilidades clínicas y comunicacionales para la atención integral de personas recién nacidas de término, sanas y vigorosas, la madre y la familia durante el proceso de nacimiento.

### Objetivos específicos:

- Identificar elementos necesarios para la recepción de un nacimiento.
- Realizar las acciones sensibles al tiempo de la primera hora de vida: puesta al pecho precoz, contacto piel a piel, clampeo oportuno o tardío de cordón umbilical.
- Adquirir las siguientes prácticas: Termorregulación, identificación, determinación de la edad gestacional.
- Realizar el examen físico de personas recién nacidas a término, sanas.
- Realizar las rutinas que previenen complicaciones posteriores (profilaxis) justificando su procedencia.
- Conocer y realizar las pesquisas recomendadas en la persona recién nacida.
- Realizar una correcta recomendación de lactancia y sueño.

### Bibliografía Obligatoria:

1. **La misma que el LHC anterior**
2. Santos N. Atención del RN en la sala de Partos. En: Reichenbach J. La Hora de Oro en Pediatría. Vol 1. 1° ed. La Plata: FEMEBA; 2018. p. 49-58
3. Algoritmo recepción disponible en:  
[https://www.sap.org.ar/docs/pdf/files\\_algoritmorcpneo11-22\\_1669216804.pdf](https://www.sap.org.ar/docs/pdf/files_algoritmorcpneo11-22_1669216804.pdf)
4. Grinenco S, Alborno C, Crespo G, Bosaleh MJ, Brenner P, Aiello H, Otaño L, et al. Consenso sobre detección temprana de las cardiopatías congénitas. Arch Argent Pediatr. 2025;e202410580. Primero en Internet 13-FEB-2025. Disponible en:  
<https://www.sap.org.ar/storage/app/uploads/public/67d/09b/235/67d09b2351817050151943.pdf>
5. Programa nacional de detección temprana y atención de la hipoacusia. Dirección nacional de maternidad e infancia. Ministerio de salud de la Nación. Pesquisa neonatal auditiva. Edición 2014 (pág.14-15).
6. Exploración del reflejo rojo en recién nacidos, lactantes y niños. American Academy of Pediatrics (Section on Ophthalmology) Disponible en:  
<https://www.elsevier.es/es-revista-pediatrics-10-articulo-exploracion-del-reflejo-rojo-recien-13131059>
7. Nally AP, Galeano MA. Recomendaciones en la pesquisa y diagnóstico de la displasia del desarrollo de las caderas. Arch Argent Pediatr 2021;S159-S170. Disponible en:  
<https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2021/v119n4a37s.pdf>
8. Material de apoyo: videos realizados por la UA para las simulaciones.  
**ES INDISPENSABLE VER LOS VIDEOS ANTES DE REALIZAR EL LHC**
  -  Primer hora de vida
  -  Profilaxis del recién nacido
  - [Examen físico](#)
  - [Reflejos del recién nacido](#)

### Materiales QUE DEBE TRAER el estudiante:

- ★ Guía del LHC anterior resuelta
- ★ Traer impresa todas las **listas de chequeo**.
- ★ Traer **guantes** descartables.

### TRABAJAMOS CON EL CASO DE LA GUÍA DEL MÓDULO NEONATAL PARTE 1

**Situación clínica:** Usted es la/el pediatra del hospital, al lado suyo está Camila de 30 años que se encuentra en trabajo de parto. Se encuentra esperando con ropa esteril y guantes, para realizar la recepción de su hijo Pedro de 39 semanas de EG por FUM.

**DATOS DE LA MADRE:** Camila tuvo un embarazo controlado, segunda gesta, 1 aborto, serologías toxo pasada resto negativas, hisopado vaginal strep agalactiae negativo, sin ninguna complicación. Grupo y factor A RH (+)

**DATOS DEL RECIÉN NACIDO: Pedro** EG 39 semanas, tono en flexión acorde a una persona recién nacida sana, FC 130 x min, respira con adecuado esfuerzo respiratorio sin uso de músculos accesorios. Color cianótico que se vuelve rosado a los 2 minutos de vida. Adecuada adaptación a la vida extrauterina

| LISTA DE COTEJO PRIMER HORA DE VIDA |                                                                                                                                              | SI | NO |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1                                   | Recibe a la persona recién nacida con paño esteril                                                                                           |    |    |
| 2                                   | Realiza de inmediato contacto piel a piel sin interferencias                                                                                 |    |    |
| 3                                   | Mientras seca y estimula a la persona recién nacida realiza las 3 preguntas para determinar la necesidad de iniciar maniobras de reanimación |    |    |
| 4                                   | Evalúa si es gestación a término                                                                                                             |    |    |
| 5                                   | Evalúa si Respira o llora (presenta adecuado esfuerzo respiratorio)                                                                          |    |    |
| 6                                   | Evalúa el Tono (miembros en flexión y movilidad activa)                                                                                      |    |    |
| 7                                   | Evalúa la frecuencia cardiaca en el cordón umbilical (>100 lpm)                                                                              |    |    |
| 8                                   | Evalúa el estado clínico y de vigilia de la madre.                                                                                           |    |    |
| 9                                   | Dice qué es un recién nacido vigoroso y lo deja con su madre                                                                                 |    |    |
| 10                                  | Dice en voz alta qué mantiene la temperatura. Cambia compresa húmeda por seca. La compresa cubre totalmente el cuerpo del recién nacido.     |    |    |
| 11                                  | Coloca Gorro                                                                                                                                 |    |    |
| 12                                  | Realiza Test de APGAR al minuto de vida para valorar tolerancia del RN al proceso de nacimiento. (puntaje=9)                                 |    |    |
| 13                                  | Realiza identificación del RN y coloca pulsera con misma identificación a la madre.                                                          |    |    |
| 14                                  | Dice que realiza Clampeo oportuno o tardío del cordón umbilical (1-3 minutos o hasta que deje de latir)                                      |    |    |
| 15                                  | Clampea cordón con 2 pinzas Kocher separadas por 10 cm y corta con tijera esteril entre medio de ellas.                                      |    |    |
| 16                                  | Coloca clamp en el cordón del recién nacido a 2-3 cm desde la piel del bebe y corta el cordón distal al clamp con hoja de bisturi esteril.   |    |    |
| 17                                  | Observa el interior del cordón con presencia de 2 arterias y 1 vena                                                                          |    |    |
| 18                                  | Realiza Test de APGAR a los cinco minutos para valorar tolerancia de la persona recién nacida a la vida extrauterina (puntaje máx =10)       |    |    |
| 18                                  | Dice en voz alta que el Test de Apgar es 9/10 (9 al 1er min y 10 a los 5 min)                                                                |    |    |
| 19                                  | Dice que alienta al binomio a mantener contacto piel con piel iniciando la puesta al pecho sin separación hasta la toma del primer calostro. |    |    |
| 20                                  | Dice que permanece observando al binomio con mínima interferencia y que favorece que el/la acompañante permanezca a su lado.                 |    |    |

### Pinzamiento del cordón umbilical



### EN UN SEGUNDO MOMENTO SE REALIZARÁN ACCIONES NO SENSIBLES AL TIEMPO COMO: **Profilaxis del recién nacido:**

Se realizarán las rutinas de profilaxis como aplicación de vitamina k, aplicación de ungüento de eritromicina oftálmica, aplicación de vacuna hep. B.

|    | Lista de Cotejo de <b>PROFILAXIS DEL NACIMIENTO</b>                                                                                                                             | SI | NO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | <b>Higieniza sus manos</b> antes de realizar la práctica y se <b>presenta</b> .                                                                                                 |    |    |
| 2  | Observa a la persona recién nacida y deja al <b>descubierto sus muslos</b> .                                                                                                    |    |    |
| 3  | Considera alguna <b>estrategia NO farmacológica</b> para el manejo del dolor (puesta al pecho en contacto piel con piel si fuera posible / contención mediante posicionamiento) |    |    |
| 4  | Informa a quien acompaña al bebé que va a aplicar una inyección intramuscular de <b>Vitamina K</b> para prevenir la hemorragia neonatal y pide permiso.                         |    |    |
| 5  | Lee la ampolla de vitamina k en voz alta                                                                                                                                        |    |    |
| 6  | Carga con la aguja la jeringa de 1 cm, de vit K                                                                                                                                 |    |    |
| 7  | Cambia aguja para aplicar                                                                                                                                                       |    |    |
| 8  | Realiza limpieza / antisepsia en el muslo del Recién Nacido                                                                                                                     |    |    |
| 9  | Aplica en forma intramuscular 90° la vit k en región anterolateral del muslo                                                                                                    |    |    |
| 10 | Descarta adecuadamente la aguja en descartador y jeringa en bolsa roja                                                                                                          |    |    |
| 11 | Toma ampolla de <b>Vacuna contra la Hep. B</b> y lee en voz alta                                                                                                                |    |    |
| 12 | Explica a quien acompaña al bebé que va a aplicar una inyección IM; la primera dosis de la vacuna que previene la infección por Hepatitis B y pide permiso.                     |    |    |
| 13 | Carga con la aguja la jeringa de 1 cm, de vacuna Hepatitis B                                                                                                                    |    |    |
| 14 | Cambia aguja para aplicar                                                                                                                                                       |    |    |
| 15 | Realiza limpieza / antisepsia en el muslo del Recién Nacido                                                                                                                     |    |    |
| 16 | Aplica en forma intramuscular 90° la vacuna hepatitis b en región anterolateral del otro muslo                                                                                  |    |    |
| 17 | Descarta adecuadamente la aguja y jeringa en descartador                                                                                                                        |    |    |
| 18 | Explica a quien acompaña al bebé que va a proceder a aplicar <b>Eritromicina</b> intraocular para prevenir la oftalmia gonocócica (o conjuntivitis por Gonococo)                |    |    |
| 19 | Aplica Eritromicina en ambos ojos, desde el ángulo interno del ojo hacia afuera                                                                                                 |    |    |
| 20 | Higieniza las manos luego de la práctica                                                                                                                                        |    |    |

**Realice** la simulación del examen físico del recién nacido utilizando la lista de cotejo.

|    | <b>EXAMEN FÍSICO DE LA PERSONA RECIÉN NACIDA</b>                                                                                                                       | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Se presenta a la familia y pregunta el nombre del paciente.                                                                                                            |           |           |
| 2  | Pide permiso para realizar examen físico                                                                                                                               |           |           |
| 3  | Se lava las manos                                                                                                                                                      |           |           |
| 4  | Dice que realizará el examen físico de forma céfalo caudal y desviste al recién nacido                                                                                 |           |           |
| 5  | Dice e inspecciona el estado general del paciente.                                                                                                                     |           |           |
| 6  | Realiza y dice que evalúa la coloración de la piel, hemangiomas planos                                                                                                 |           |           |
| 7  | Realiza y dice que examina faneras (pelos, uñas)                                                                                                                       |           |           |
| 8  | Dice que evalúa el aspecto nutricional del paciente y el tono muscular                                                                                                 |           |           |
| 9  | Realiza evaluación de signos vitales. Frecuencia Cardíaca Frecuencia Respiratoria, Temperatura y saturación de oxígeno                                                 |           |           |
| 10 | Dice y evalúa la forma del cráneo                                                                                                                                      |           |           |
| 11 | Dice y evalúa la presencia de caput o de cefalohematoma                                                                                                                |           |           |
| 12 | Dice y evalúa la presencia y forma de la fontanela anterior.                                                                                                           |           |           |
| 13 | Dice y evalúa la presencia y forma de la fontanela posterior.                                                                                                          |           |           |
| 14 | Dice que evalúa facie.                                                                                                                                                 |           |           |
| 15 | Dice y evalúa la presencia de globos oculares y movilidad ocular                                                                                                       |           |           |
| 16 | Dice y evalúa la permeabilidad de las narinas.                                                                                                                         |           |           |
| 17 | Dice y evalúa anatomía de pabellón auricular.                                                                                                                          |           |           |
| 18 | Dice y evalúa implantación de pabellón auricular.                                                                                                                      |           |           |
| 19 | Dice y evalúa la presencia de dientes.                                                                                                                                 |           |           |
| 20 | Dice y evalúa el frenillo lingual.                                                                                                                                     |           |           |
| 21 | Dice y evalúa paladar duro y blando                                                                                                                                    |           |           |
| 22 | Dice y evalúa cuello                                                                                                                                                   |           |           |
| 23 | Dice y evalúa clavículas                                                                                                                                               |           |           |
| 24 | Realiza y dice auscultación pulmonar anterior simétrica y comparativa.                                                                                                 |           |           |
| 25 | Realiza y dice auscultación pulmonar posterior simétrica y comparativa                                                                                                 |           |           |
| 26 | Dice que evalúa uso de músculos respiratorios accesorios                                                                                                               |           |           |
| 27 | Dice y ausculta Ap. cardiovascular en 4 focos: pulmonar, aórtico, mitral y tricuspídeo                                                                                 |           |           |
| 28 | Dice y toma pulsos braquial y femoral de forma simétrica y comparativa. Puede hacer los dos pulsos braquiales y luego los dos femorales o braquial-femoral comparativo |           |           |
| 29 | Dice que inspecciona el abdomen y ausculta los ruidos hidroaéreos.                                                                                                     |           |           |
| 30 | Dice y realiza una palpación superficial y luego profunda del abdomen.                                                                                                 |           |           |
| 31 | Realiza palpación de hígado                                                                                                                                            |           |           |
| 32 | Realiza palpación de bazo                                                                                                                                              |           |           |
| 33 | Realiza maniobra de peloteo renal                                                                                                                                      |           |           |
| 34 | Dice y realiza percusión del abdomen                                                                                                                                   |           |           |
| 35 | Dice que evalúa presencia de 2 arterias y una vena en cordón umbilical                                                                                                 |           |           |
| 36 | Dice que evalúa genitales femeninos: Labios mayores y menores, capuchon de clitoris                                                                                    |           |           |
| 37 | Dice que evalúa genitales masculinos: presencia de pene: epispadias, hipospadias.                                                                                      |           |           |
| 38 | Dice que evalúa Testículos en bolsa, presencia de hidrocele (transluminiscencia)                                                                                       |           |           |
| 39 | Dice que evalúa permeabilidad del ano                                                                                                                                  |           |           |
| 40 | Dice que evalúa Aparato osteoarticular: presencia de extremidades y dedos                                                                                              |           |           |
| 41 | Examina columna                                                                                                                                                        |           |           |
| 42 | Realiza y dice que examina región dorsal presencia de mechones, hemangiomas en línea media.                                                                            |           |           |
| 43 | Evalúa presencia y fondo de Fosa pilonidal                                                                                                                             |           |           |
| 44 | Deja maniobras invasivas para el final. Dice en voz alta que evalúa caderas: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Realiza Maniobra de Barlow</li> </ul>            |           |           |
| 45 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Realiza maniobra de Ortolani</li> </ul>                                                                                       |           |           |



|    |                                                                                                                |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 46 | Dice y evalúa reflejos del recién nacido                                                                       |  |  |
| 47 | Valora la edad gestacional con el Método capurro                                                               |  |  |
| 48 | Pesa al Recién Nacido                                                                                          |  |  |
| 49 | Mide el perímetro cefálico del Recién Nacido                                                                   |  |  |
| 50 | Mide la talla del Recién Nacido                                                                                |  |  |
| 51 | Deja al recién nacido en contacto piel con piel mientras evalúa la lactancia (prendida, acoplamiento, succión) |  |  |
| 52 | Comunica amablemente los datos obtenidos del examen físico                                                     |  |  |

**MÉTODO CAPURRO:** Valoración de la edad gestacional en el recién nacido, con cinco parámetros:

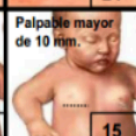
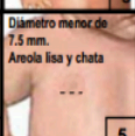
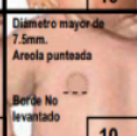
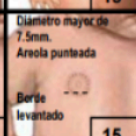
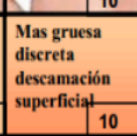
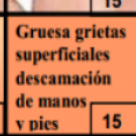
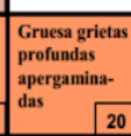
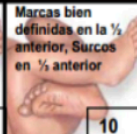
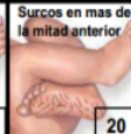
1. Forma de la oreja (pabellón)
2. Tamaño de la glándula mamaria
3. Formación del pezón
4. Textura de la piel
5. Pliegues plantares

### Repasamos el ejercicio de la guía de la semana pasada:

Al examen físico, Pedro presenta estas características:

- Forma de la oreja (pabellón): todo el borde superior incurvado
- Tamaño de la glándula mamaria: palpable 9 mm
- Formación del pezón: diámetro de 8mm, areola punteada borde NO levantado
- Textura de la piel: gruesa grietas superficiales, descamación de manos y pies
- Pliegues plantares: surcos en la mitad anterior

Utilice el MÉTODO CAPURRO y calcule la edad gestacional de Pedro.

|                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forma de la OREJA (Pabellón)</b> | <br>Aplanada, sin incurvación<br>0 | <br>Borde superior parcialmente incurvado<br>8         | <br>Todo el borde superior incurvado<br>16                                 | <br>Pabellón totalmente incurvado<br>24                            |                                                                                                                                      |
| <b>Tamaño de GLÁNDULA MAMARIA</b>   | <br>No Palpable<br>0               | <br>Palpable menor de 5 mm.<br>5                       | <br>Palpable entre 5 y 10 mm.<br>10                                        | <br>Palpable mayor de 10 mm.<br>15                                 |                                                                                                                                      |
| <b>Formación del PEZÓN</b>          | <br>Apenas visible sin areola<br>0 | <br>Diámetro menor de 7.5 mm. Areola lisa y chata<br>5 | <br>Diámetro mayor de 7.5mm. Areola punteada<br>10                         | <br>Diámetro mayor de 7.5mm. Areola punteada<br>15                 |                                                                                                                                      |
| <b>TEXTURA de la PIEL</b>           | <br>Muy fina gelatinosa<br>0       | <br>Fina lisa<br>5                                     | <br>Mas gruesa discreta descamación superficial<br>10                      | <br>Gruesa grietas superficiales descamación de manos y pies<br>15 | <br>Gruesa grietas profundas apergaminadas<br>20 |
| <b>PLIEGUES PLANTARES</b>           | <br>Sin pliegues<br>0              | <br>Marcas mal definidas en la mitad anterior<br>5     | <br>Marcas bien definidas en la 1/2 anterior, Surcos en 1/2 anterior<br>10 | <br>Surcos en la mitad anterior<br>15                              | <br>Surcos en mas de la mitad anterior<br>20     |

EDAD GESTACIONAL **ED = 204 + PUNTAJE**

**7**

EJEMPLO:  $\frac{204 + 56}{7} = 37.1 \text{ SEMANAS}$

|   | Reflejos del Recién Nacido                                                                                                                                                                                                                                   | SI | NO |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1 | Se presenta a la familia y se lava las manos                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
| 2 | Explica de qué se trata la exploración, para que se hace y pide permiso para realizarla.                                                                                                                                                                     |    |    |
| 3 | <b>Reflejo de Moro:</b> se desencadena en respuesta a un estímulo brusco o a una deflexión brusca de la cabeza. Tiene varias fases: primero el RN abre los brazos para luego cerrarlos en actitud de abrazo acompañado de flexión del cuerpo y luego llanto. |    |    |
| 4 | <b>Prehensión palmar y plantar:</b> al aplicar presión en las palmas y en la planta del pie, el RN flexiona sus dedos empujando la mano o flexionando los dedos del pie.                                                                                     |    |    |
| 5 | <b>Búsqueda:</b> el RN vuelve su cabeza hacia al lado donde se le aplica un estímulo en mejilla o peribucal, buscando el pezón de la madre.                                                                                                                  |    |    |
| 6 | <b>Succión:</b> movimiento rítmico y coordinado de lengua y boca al colocar un objeto (chupete, dedo) dentro de ella.                                                                                                                                        |    |    |
| 7 | <b>Marcha automática:</b> al sostener al RN desde el tronco e inclinándose levemente hacia adelante, da unos pasos en forma automática.                                                                                                                      |    |    |
| 8 | <b>Reflejo tónico cervical (posición de esgrima):</b> consiste en mover la cabeza hacia un lado, extendiendo también de forma refleja el brazo y la pierna de ese lado al que mira la cabeza y flexionando las extremidades del costado contrario            |    |    |
| 9 | Dice que finaliza la exploración y comunica a la familia los hallazgos                                                                                                                                                                                       |    |    |

Tabla 5. Reflejos primitivos

| Reflejo                       | Cómo se estimula                                                                                                                                                               | Fechas                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Búsqueda                      | Al tocar la mejilla: desviación de la comisura bucal y giro de cabeza hacia ese lado                                                                                           | Desaparece al mes de vida                       |
| Succión                       | Al tocar el dorso de la lengua: adopta forma cóncava y realiza succión                                                                                                         | Desaparece a los 3 meses (patológico >6 meses)  |
| Moro                          | Se incorpora ligeramente en decúbito supino y al soltarlo se produce abducción y extensión de brazos (1.ª fase) seguido de aducción y flexión (2.ª fase) acompañadas de llanto | Desaparece a los 3 meses                        |
| Marcha automática             | En posición vertical al apoyar los pies, da unos pasos                                                                                                                         | Desaparece al mes (patológico >3 meses)         |
| Galant                        | El estímulo paravertebral desde debajo de la escápula hasta encima de la cresta iliaca produce incurvación del tronco hacia ese lado                                           | Desaparece al 5.º mes                           |
| Preñión palmar                | Al introducir el pulgar en mano se produce la flexión de los dedos                                                                                                             | 4-5 meses                                       |
| Preñión plantar               | Al tocar la planta a la altura de la base de los dedos se produce la flexión de los dedos                                                                                      | 9-12 meses                                      |
| Reflejo acústico facial (RAF) | Parpadeo ante el ruido                                                                                                                                                         | Patológico si no aparece al 4.º mes             |
| Reflejo óptico facial (ROF)   | Parpadeo al aproximarle un objeto a la cara                                                                                                                                    | Patológico si no aparece al 6.º mes             |
| Paracaídas                    | Al inclinar al niño hacia el frente: extiende EEES y se apoya en palmas                                                                                                        | Aparece al 6.º mes                              |
| Suprapúbico                   | Tras una presión suprapúbica, realiza una extensión tónica de las extremidades inferiores con aducción con equino                                                              | Desaparece al mes (patológico >3 meses)         |
| Cruzado extensor              | Al realizar presión sobre el cotilo con la pierna flexionada se produce una extensión tónica con equino de la extremidad contralateral                                         | Desaparece al mes y medio (patológico >3 meses) |

**Pesquisas recomendadas:** Se realizarán con el RN en la internación conjunta los Screening correspondientes antes del alta del paciente.

- FEI
- OEA
- Cardiopatías Congénitas (Oximetría de pulso)
- Caderas (USAR CHECKLIST ESPECÍFICO)
- Reflejo rojo.

| LISTA DE COTEJO <b>Pesquisas en recién nacidos en el alojamiento</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI | NO |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1                                                                    | <p><b>Se presenta y pide permiso</b> para realizar el procedimiento.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dice en voz alta que <b>Realiza reflejo rojo.</b></li> <li>2. Dice que debe llevarse a cabo en un cuarto a oscuras (para dilatar la pupila y qué entre más luz)</li> <li>3. Coloca la luz del oftalmoscopio a una distancia aproximada de 30-45 cm y enfoca ambos ojos del niño simultáneamente</li> <li>4. Evalúa la transparencia ocular y la retina y observa el reflejo del fondo de ambos ojos a través de la pupila.</li> <li>5. El reflejo debe ser brillante, de color homogéneo rojizo-naranja y simétrico en color y forma en ambos ojos</li> <li>6. Comunica el resultado y pregunta dudas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| 2                                                                    | <p><b>Pide permiso</b> para realizar la <b>pesquisa de hipoacusia</b> con las otoemisiones acústicas luego de las 36/48 hs de recién nacido.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dice que explica a la mamá/papá que la pesquisa es indolora y que busca detectar hipoacusia.</li> <li>2. Se necesita un lugar silencioso y que el niño esté tranquilo</li> <li>3. Se coloca el aparato en cada oído por separado y se evalúa.</li> <li>4. Dice que si PASA ambos oídos se considera normal</li> <li>5. Dice que si NO PASA algún oído o ambos, se debe repetir la prueba antes del mes de vida, y si esa tampoco pasa se deriva al especialista ORL (PEAT)</li> <li>6. Comunica el resultado y pregunta dudas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| 3                                                                    | <p>La <b>pesquisa de Cardiopatías congénitas</b> se realiza luego de las 24 horas de vida y <b>lo más próximo al egreso</b> que sea posible para evitar los errores de interpretación dados por la presencia del ductus.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Explica a la madre/padre que va a realizar la pesquisa y pide permiso</li> <li>2. Coloca saturometro en mano derecha (preductal)</li> <li>3. Coloca saturometro en pie derecho o izquierdo ( postductal)</li> </ol> <p>Evalúa resultados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dice que la PRUEBA es NEGATIVA si los valores de saturometría son mayores iguales a 95% y la diferencia entre la mano derecha y el pie es de 3 puntos o menos y que ese bebé puede ser dado de alta.</li> <li>2. Dice que la PRUEBA es POSITIVA si la saturación en la mano derecha o cualquiera de los dos pies es menor o igual a 89%. Dice que NO se puede dar de alta y que sospecha cardiopatía.</li> <li>3. Dice que si los valores de saturometría se sitúan entre 90-94%, o bien con una diferencia entre la mano derecha y el pie mayor o igual a 4 puntos, se deberá repetir la prueba después de 1 hora, siguiendo el algoritmo.</li> <li>4. Comunica el resultado y pregunta dudas.</li> </ol> |    |    |



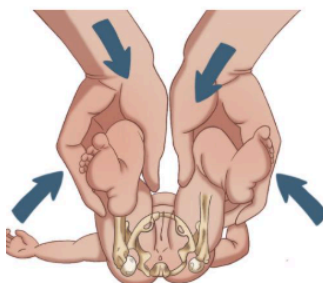
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4 | <p>Pide permiso para realizar la Pesquisa de <b>Displasia del desarrollo de Cadera</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Realiza la maniobra de Barlow</b> con el niño acostado en decúbito supino en la camilla, de frente a nosotros, <b>en cada pierna por separado</b>.<br/>Una mano estabiliza la pelvis mientras la otra sostiene la rodilla y flexiona la cadera formando un ángulo de 90°; los dedos de esa mano deben colocarse por encima del trocánter mayor y aducir (aproximar a la línea media) la cadera de 10° a 20° aplicando una presión suave posterior.<br/>En <b>caso de luxar la cadera se debe detectar un clic</b> correspondiente a la cabeza del fémur que se desplaza del borde del acetábulo.</li> <li>2. <b>Realiza la maniobra de Ortolani</b><br/>Se deben flexionar ambas piernas y caderas hasta 90°. El pulgar sostiene la parte interna de la rodilla mientras que el 2.º y el 3.º dedo se colocan sobre el trocánter mayor abduciendo la cadera en forma paulatina mientras los dedos intentan <b>introducir la cabeza dislocada del fémur dentro del acetábulo. Si se oye un clic, será porque la cadera se redujo.</b></li> <li>3. Comunica el resultado y pregunta dudas.<br/><b>MANIOBRA POSITIVA: cadera inestable (luxable)</b><br/><b>MANIOBRA NEGATIVA: cadera sana (no luxable)</b></li> </ol> <p>(Recordar que la pesquisa se realiza desde el nacimiento, y en cada control mensual hasta el año de vida, siempre evaluar los Factores de riesgo, y si es necesario solicitar estudios complementarios)</p> |  |  |
| 5 | <p>Pide permiso para realizar la <b>Pesquisa Metabólica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dice que se tomará la muestra mediante punción del talón a todo recién nacido a partir de las 36 horas de vida y previo al egreso (siempre que haya iniciado la alimentación oral)</li> <li>2. Dice que le explica a la madre/ padre que va a realizar la pesquisa para detectar enfermedades congénitas, mediante punción del talón.</li> <li>3. Procede a llenar los datos de la tarjeta recolectora con los datos de la madre y del recién nacido</li> <li>4. Se lava las manos, calienta el talón para vasodilatar la zona de punción y facilitar la salida de sangre</li> <li>5. Limpia la zona de punción con alcohol. El exceso de alcohol se debe secar con una gasa estéril</li> <li>6. Ofrece a la mamá que ponga al niño al pecho (pecho analgesia)</li> <li>7. Realiza la punción utilizando una lanceta estéril, descartable, con una punta de 2 mm de profundidad.</li> <li>8. Descarta la primera gota de sangre, limpiando con gasa estéril.</li> <li>9. Dice que deja formar en el talón una gota de sangre abundante y que procede a dejarla caer directamente en el papel de filtro de la tarjeta, colocando una única gota de sangre por círculo.</li> <li>10. Limpia la zona con gasa esteril</li> <li>11. Le explica a la mamá que debe recordar buscar los resultados en 45 días aproximadamente.</li> <li>12. Pregunta dudas</li> </ol>                                                                                                 |  |  |

|    | Lista de Cotejo para Examen físico de caderas                                                                                                                                | SI | NO |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | Se presenta a la familia y se lava las manos                                                                                                                                 |    |    |
| 2  | Explica de qué se trata el procedimiento y para que se hace.                                                                                                                 |    |    |
| 3  | Pide permiso para revisar y deja maniobras invasivas para el final                                                                                                           |    |    |
| 4  | Nombra los factores de riesgo de padecer patología luxante de cadera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sexo femenino</li> </ul>                                      |    |    |
| 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primogenita</li> </ul>                                                                                                              |    |    |
| 6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación podálica,</li> </ul>                                                                                                   |    |    |
| 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antecedentes familiares de displasia,</li> </ul>                                                                                    |    |    |
| 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signo de Ortolani-Barlow positivo</li> </ul>                                                                                        |    |    |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presencia de otras malformaciones (principalmente en los pies)</li> </ul>                                                           |    |    |
| 10 | Evalúa simetría de pliegues anteriores de miembros inferiores                                                                                                                |    |    |
| 11 | Evalúa simetría de pliegues posteriores de miembros inferiores                                                                                                               |    |    |
| 12 | Evalúa longitud de miembros inferiores. Signo de Galeazzi                                                                                                                    |    |    |
| 13 | Evalúa pies                                                                                                                                                                  |    |    |
| 14 | Realiza <b>Maniobra de Barlow</b> con el niño acostado en decúbito supino en la camilla, de frente a nosotros.                                                               |    |    |
| 15 | Con una mano estabiliza la pelvis mientras la otra sostiene la rodilla y flexiona la cadera formando un ángulo de 90°;                                                       |    |    |
| 16 | Coloca los dedos de esa mano por encima del trocánter mayor y aduce (aproximar a la línea media) la cadera de 10° a 20° aplicando una presión suave posterior                |    |    |
| 17 | Dice en voz alta que la maniobra <b>luxa una cadera displásica, si detecta un clic</b> correspondiente a la cabeza del fémur que se desplaza del borde del acetábulo.        |    |    |
| 18 | Realiza la maniobra en cada pierna por separado.                                                                                                                             |    |    |
| 19 | Realiza <b>Maniobra de Ortolani</b> : con el niño en la misma postura que se utilizó en la maniobra de Barlow.                                                               |    |    |
| 20 | Flexiona ambas piernas y caderas hasta 90°.                                                                                                                                  |    |    |
| 21 | Coloca el pulgar sosteniendo la parte interna de la rodilla mientras que el 2.do y el 3.er dedo se colocan sobre el trocánter mayor abduciendo la cadera lentamente          |    |    |
| 22 | Intenta con los dedos introducir la cabeza dislocada del fémur dentro del acetábulo. <b>Si se oye un clic, será porque la cadera se redujo</b>                               |    |    |
| 23 | Informa a la familia el resultado de la exploración y las maniobras<br>POSITIVO: luxa y /o reduce la cadera (DDC). Solicito estudios de imágenes.<br>NEGATIVO: Cadera normal |    |    |

## Displasia congénita de cadera

Su diagnóstico en el recién nacido se basa fundamentalmente en dos maniobras

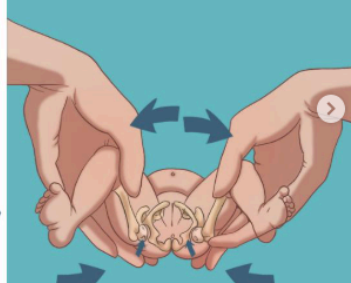
### Maniobra de Barlow



Aducción de la cadera y presión posterior

**Luxa la cadera**

### Maniobra de Ortolani



Abducción de cadera y presión anterior

**Reposiciona la cadera**



## Toma y manipulación de las muestras

### Instrucciones para el personal de salud

La pesquisa neonatal permite detectar en los recién nacidos **deficiencias metabólicas congénitas** que pueden ocasionarles secuelas graves y permanentes.

**Su éxito depende de la calidad de la muestra obtenida, de su manipulación y su despacho al laboratorio.** Estas instrucciones son una herramienta clave para la salud y la vida de nuestros niños.

1. Tome la muestra **antes del alta**. Si es posible, **entre las 48 horas y el 5º día de vida, 24 horas después de que el niño haya comenzado a alimentarse.**

Si el niño debe recibir una transfusión, tómelas antes.

Si es un niño de bajo peso (<1500 g) repita la muestra cada 15 días hasta que haya alcanzado los 2000 g.

2. Lávese las manos, colóquese los guantes y descártelos al terminar el procedimiento con cada niño. **Para realizar otra extracción, repita este paso.**

3. Acueste al bebé decúbito dorsal, con el pie en el que hará la punción más bajo que el resto del cuerpo.

4. Masaje o entibie ese talón para vasodilatar la zona.

5. Identifique el área de punción, desinfecte **con alcohol** y retire el excedente con gasa estéril seca.

6. Haga la punción en la zona indicada en el gráfico y **elimine la primera gota de sangre** con gasa estéril seca.

7. Deje que se forme una gota abundante y aplíquela directamente en el centro de uno de los círculos, llenándolo **por completo**. (Evite presionar el talón contra la tarjeta así como superponer gotas en el mismo círculo). Verifique que la sangre sea visible en el reverso de la tarjeta. Repita hasta llenar **todos los círculos**.

8. Al terminar, eleve el talón del niño por sobre su cuerpo, presione con una gasa estéril hasta que deje de sangrar y coloque una cinta adhesiva sobre la gasa.



9. Deje secar las tarjetas bien **separadas entre sí**, en un local ventilado, lejos de la luz directa del sol, **durante un mínimo de 3 horas.**

10. Guarde las tarjetas en el sobre **correspondiente** para su envío al laboratorio.

Al ponerlas en el sobre, **rótelas 180º alternadamente** para que las muestras

de tarjetas distintas no tomen contacto entre sí. Pueden ser conservadas dentro del sobre, a temperatura ambiente, por no más de 5 días.

### Muestras válidas



- Mancha de sangre del diámetro de los círculos.
- Distribución homogénea sobre ambos lados del papel.
- Sin coágulos de sangre.
- Sin rayados ni coloración inadecuada.
- Llenado de todos los círculos.

### Muestras NO válidas

- Tarjeta con muestra insuficiente:



- Tarjeta con áreas sobresaturadas:



- Tarjeta con muestra diluida o contaminada:



**LLENE COMPLETAMENTE** todos los datos de la tarjeta (tanto los del niño como los de la madre). Esto es fundamental para utilizar eficazmente los resultados.

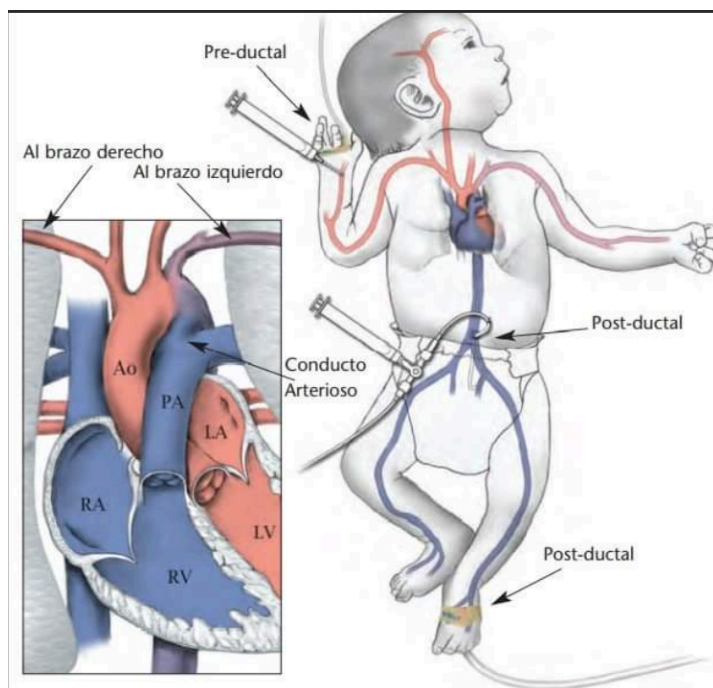
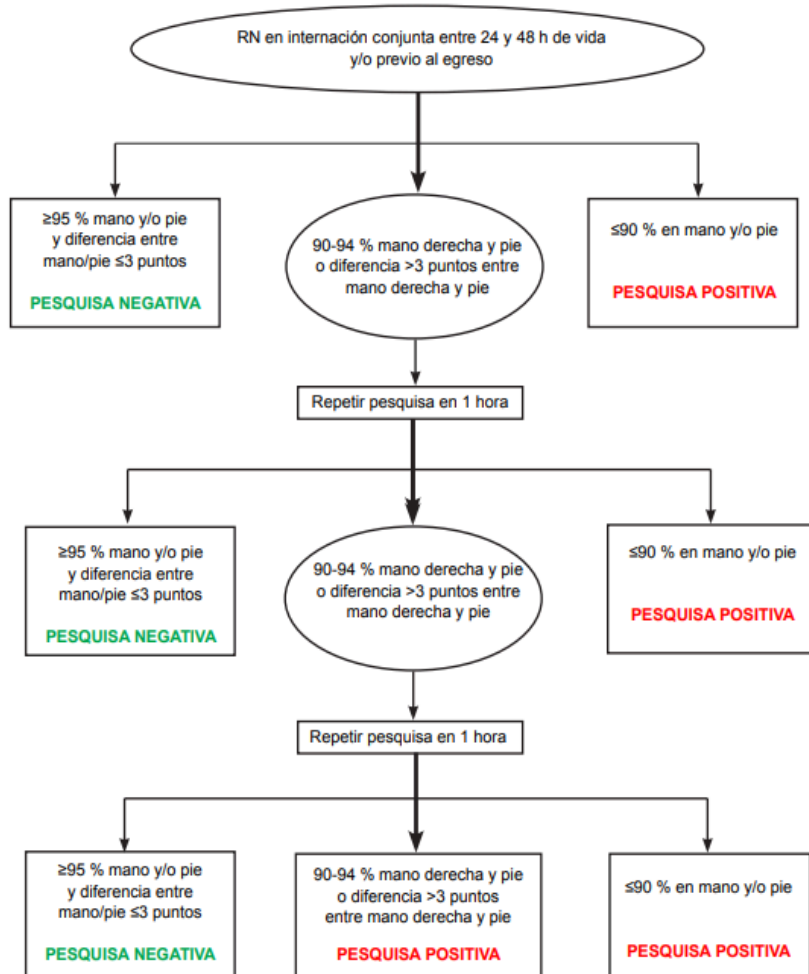
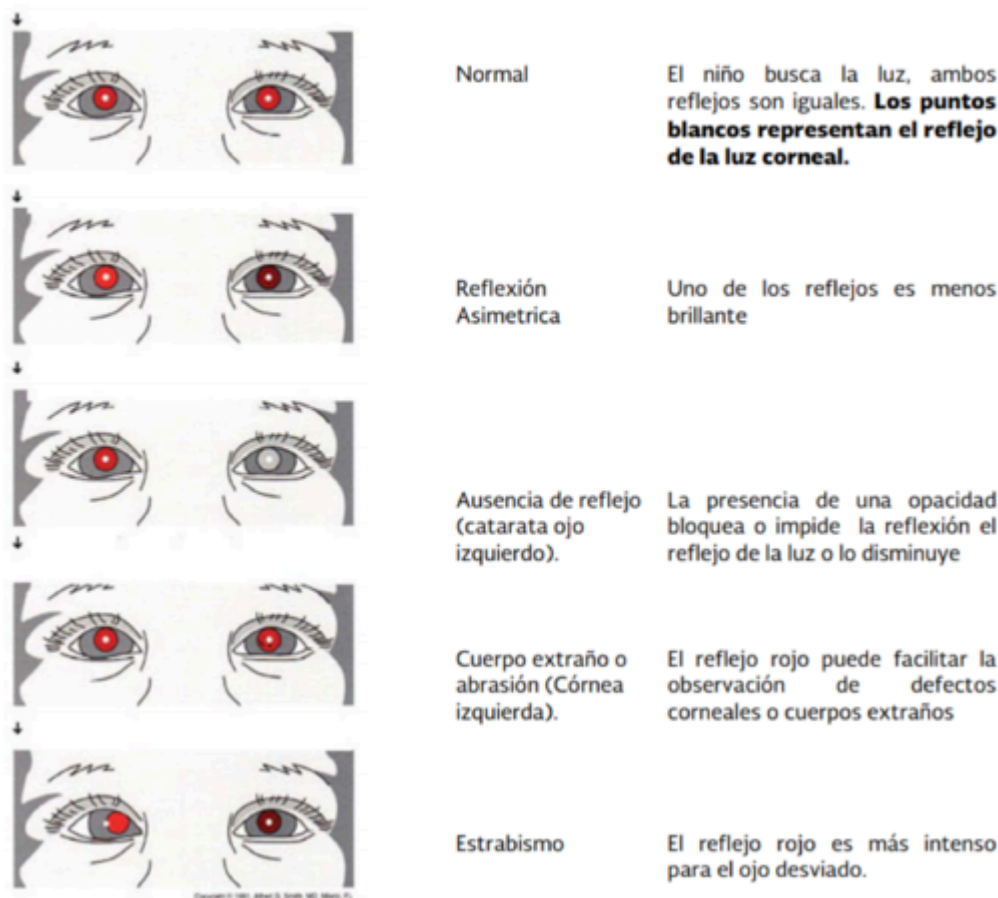


FIGURA 3. Algoritmo para pesquisa de cardiopatías congénitas por oximetría de pulso



**Figura 1. Reflejo Rojo** Tomado de American Academy of Pediatrics; Section on Ophthalmology; American Association for Pediatric Ophthalmology And Strabismus; American Academy of Ophthalmology; American Association of Certified Orthoptists. Red reflex examination in neonates, infants, and children. Pediatrics 2008



### Algoritmo de Pesquisa Neonatal Auditiva para niños sin factores de riesgo

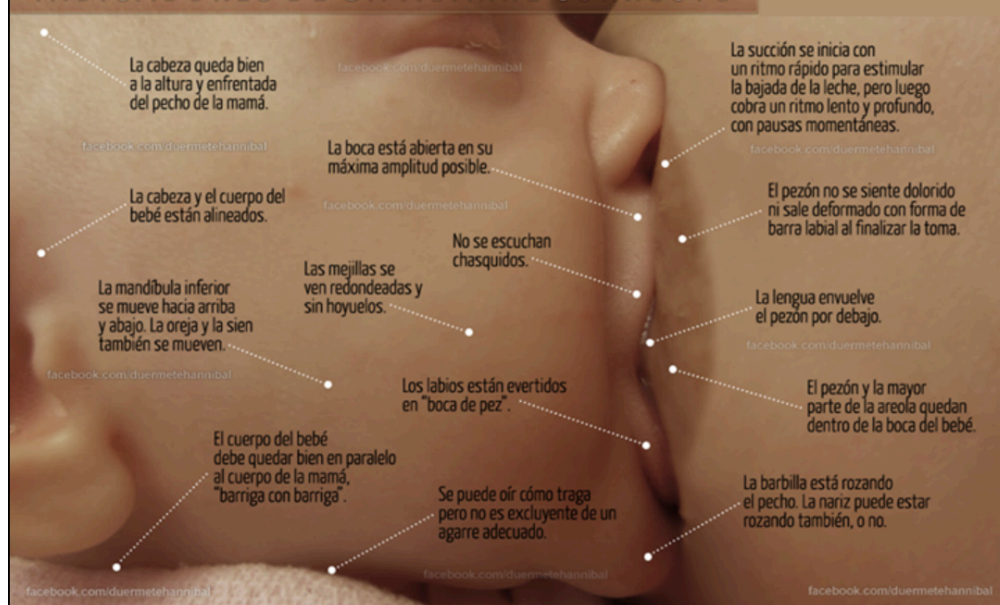


**IMPORTANTE:** Para los niños con factores de riesgo, utilizar el algoritmo de la pág. 36 (Anexo I)



|    | LACTANCIA                                                                                                                                                                          | SI | NO |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | Saluda, se presenta y dice que va a realizar una evaluación de lactancia                                                                                                           |    |    |
| 2  | Pregunta nombre del bebe y de la madre                                                                                                                                             |    |    |
| 3  | Se lava las manos                                                                                                                                                                  |    |    |
| 4  | Formula a la madre una pregunta abierta para indagar acerca de cómo se está desarrollando la lactancia.                                                                            |    |    |
| 5  | Evalúa el estado general del recién nacido                                                                                                                                         |    |    |
| 6  | Evalúa presencia de ictericia                                                                                                                                                      |    |    |
| 7  | Pregunta por diuresis: frecuencia (5-8 pañales diarios) y color                                                                                                                    |    |    |
| 8  | Pregunta por catarsis: frecuencia y color del meconio (modificación progresiva del color del meconio de negro a deposiciones amarillentas con grumos)                              |    |    |
| 9  | Pide permiso y evalúa estado de los pechos maternos: endurecimiento excesivo, estado de los pezones, presencia de lesiones relacionadas con la lactancia (agrietamiento, sangrado) |    |    |
| 10 | Evalúa e indica que el Pabellón auricular, los hombros y la cadera estén alineados al momento de la mamada.                                                                        |    |    |
| 11 | Evalúa e indica labios evertidos, el labio inferior abarcando la mayor parte posible de la areola                                                                                  |    |    |
| 12 | Evalúa que la Succión abarque pezón y areola                                                                                                                                       |    |    |
| 13 | Indica sujetar el pecho con una mano, con el pulgar y el índice colocados "en forma de C" arriba y debajo de la areola y sin comprimir el pecho                                    |    |    |
| 14 | Evalúa e indica que el mentón del recién nacido esté pegado al pecho y la nariz rozando ligeramente ( esta posición le permite respirar sin dificultad. )                          |    |    |
| 15 | Muestra diferentes posiciones para amamantar: posición clásica o tradicional, posición clásica invertida, posición de lado o pelota de fútbol, posición enfrentada o vertical      |    |    |
| 16 | Observa y escucha que el niño succiona y deglute                                                                                                                                   |    |    |
| 17 | Evalúa una toma completa                                                                                                                                                           |    |    |
| 18 | Recomienda LME exclusiva hasta los 6 meses de vida y luego de inicio de alimentación complementaria, hasta los 2 años de vida                                                      |    |    |
| 19 | Recomienda pecho según demanda del bebé                                                                                                                                            |    |    |
| 20 | Recomienda medidas de sostén para la madre: descanso, nutrición, contención y sostén afectivo.                                                                                     |    |    |
| 21 | Anima a la madre a continuar con la lactancia y da confianza                                                                                                                       |    |    |

## INDICADORES DE UN AGARRE CORRECTO



## 10 pasos para una lactancia materna exitosa

¿Sabías que el Hospital Castro Rendón tiene una política en LACTANCIA MATERNA?

- 1 **Disponer de una política** por escrito relativa a la lactancia natural.
- 2 **Capacitar a todo el personal** de salud para poner en práctica esa política.
- 3 **Informar a todas las embarazadas** de los beneficios de la lactancia natural.
- 4 **Ayudar a las madres** a iniciar la lactancia durante la primera hora siguiente al parto.
- 5 **Mostrar a las madres** cómo se debe dar de mamar al niño.
- 6 No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin **ningún otro alimento o bebida**, salvo cuando medie indicación médica.
- 7 **Facilitar el alojamiento conjunto** de las madres y los niños durante las 24 horas del día.
- 8 **Fomentar la lactancia natural** cada vez que el niño la pida.
- 9 **No dar** a los niños alimentados a pecho, **chupetes artificiales o biberones**.
- 10 **Fomentar el apoyo y acompañamiento a la lactancia**, a través del consultorio de Consejería.



El hombre y el niño.  
Encontrarán a cualquier persona de la institución.

|   | POSICIONES AMAMANTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1 | Saluda, se presenta, pregunta el nombre de la madre y recién nacido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| 2 | Realiza la “ <b>posición clásica o tradicional</b> ”. Se coloca al bebé con el tronco enfrentado y pegado a la madre. La madre lo sujeta con la mano en su espalda, apoyando la cabeza en el antebrazo, pero no muy cerca del codo para que el cuello no se flexione, lo que dificultaría el agarre. Con la otra mano dirige el pecho hacia la boca del bebé y en el momento en que éste la abre, lo acerca con suavidad al pecho.                                                                                               |    |    |
| 3 | Realiza la “ <b>posición clásica invertida</b> ”: involucra la posición clásica, excepto que el bebé se apoya sobre el brazo opuesto al seno que se ofrecerá. En esta posición, la mano apoya en el cuello y espalda alta del bebé, (en lugar de sus glúteos) y sus glúteos se apoyan en el arco del brazo materno o en una almohada sobre su regazo. Nuevamente, gira el cuerpo del bebé para que quede frente a la mama y la boca esté alineada con el pezón. La mano del lado del seno que ofrece, toma la mama en forma de c |    |    |
| 4 | Realiza la “ <b>posición de lado o pelota de fútbol</b> ”: Se coloca al bebé al costado del cuerpo materno, sosteniendo el cuello del niño con la mano homolateral al pecho que se ofrecerá, idealmente sobre un almohadón para elevar la posición, y el antebrazo materno acompaña el cuerpo del niño, quedando con la cabeza hacia el pecho y el cuerpo hacia atrás de la madre, enfrentando su vientre con el lateral de su madre.                                                                                            |    |    |
| 5 | Realiza la “ <b>posición enfrentada/vertical</b> ”: La madre se sienta en vertical y el bebé está colocado de lado con su cabeza y cuello apoyados en el antebrazo de la madre y el cuerpo en el estómago. La mamá puede ponerse una almohada o un cojín detrás y utilizar una almohada de lactancia en el regazo                                                                                                                                                                                                                |    |    |
| 6 | Realiza la “ <b>posición acostada</b> ”: La madre se encuentra reclinada de costado, apoyada sobre almohadas, enfrentando al bebé que se encontrará en la misma posición, tratando de mantener alineados ambos cuerpos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| 7 | Realiza la “ <b>posición biológica</b> ”: La madre se colocará recostada (entre 15 y 65°) boca arriba y el bebé boca abajo, en estrecho contacto piel con piel con el cuerpo de la madre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |

# POSICIONES para amamantar

El pecho se ofrece sosteniéndolo entre el pulgar y los demás dedos, con la mano en forma de «c»



Se debe ofrecer el pezón a la altura de la nariz del bebé, lo que le permitirá un mejor agarre.



Alinear bien al bebé para que su cabeza no quede torcida, sino que su hombro, su oreja y su cadera estén en la misma línea, enfrentados al cuerpo de la madre.



Acercarlo al pecho con la boca bien abierta e introducir el pezón y la mayor parte posible de aréola.



Los labios superior e inferior del bebé deben quedar abiertos. Su mentón debe quedar en contacto con el pecho, no así su nariz.



Para sacar al bebé del pecho lo mejor es introducir el dedo meñique en la comisura de su boca para romper el vacío creado, así se desprende del pecho sin jalar del pezón.



LA LECHE MATERNA ES ALIMENTO Y AMOR

|   | <b>SUEÑO SEGURO: Recomendaciones</b>                                                                                                            | SI | NO |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1 | Realiza recomendaciones para un sueño seguro del recién nacido: cuna segura: colchón firme, no debe contener almohadas, peluches ni chichoneras |    |    |
| 2 | Recomienda que la posición para dormir más segura para evitar SMS es boca arriba                                                                |    |    |
| 3 | Dice que la lactancia materna exclusiva es un factor de protección                                                                              |    |    |
| 4 | Dice que los ambientes deben permanecer libres de humo                                                                                          |    |    |
| 5 | Dice que deben evitarse sobrecalentamientos tanto en la cantidad de ropa que se le pone al bebé como en el ambiente.                            |    |    |
| 6 | Dice que los brazos del recién nacido deben quedar por arriba de las sábanas                                                                    |    |    |
| 7 | Pregunta a la familia si tienen alguna duda.                                                                                                    |    |    |